

Exame

Nome	Daniel Francisco Da Silva	Nascimento	08/07/1979 (46 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/04/2026 - 23:19:17	Tempo total	08:14:10 (494,2 min)		
Fim	26/04/2026 - 07:33:27	Tempo válido	08:04:08 (484,1 min)		

Condições na noite do exame

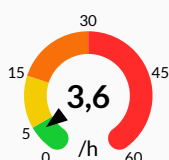
- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☐ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado

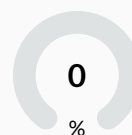
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%



Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

25 %min/hora

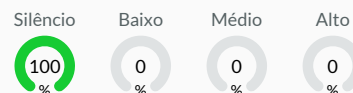
0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}



Intensidade do ronco registrado

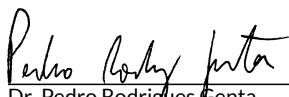


Exame de polissonografia com polissonogramas realizado no dia 25/04/2026, iniciado às 23:19 e terminado às 07:33. O tempo total de registro foi de 8h14min (494 minutos) e o tempo válido foi de 8h04min (484 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 29 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 3,6/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 97% e não permaneceu abaixo de 90% por tempo significativo. Não foram detectados eventos de ronco durante o registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 3,6/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame

Nome	Daniel Francisco Da Silva	Nascimento	08/07/1979 (46 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/04/2026 – 23:19:17	Tempo total	08:14:10 (494,2 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 23/01/2026

Peso	114 kg
Altura	1,82 m
IMC	34,4

Medicamentos

Respondido em 18/11/2024

☒ Nenhum

Sintomas Respondido em 18/11/2024

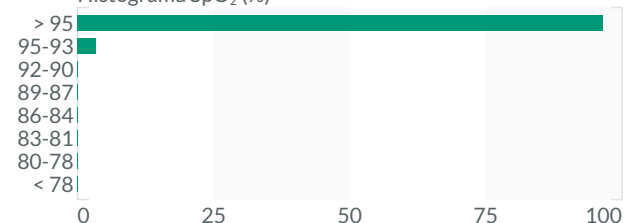
- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☐ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☐ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☒ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☐ Dificuldade de concentração
- ☐ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 18/11/2024

- ☒ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☐ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☐ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☐ Bronquite / Enfisema
- ☐ Asma

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%)



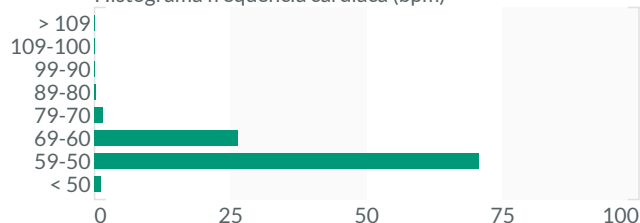
SpO ₂ mínima	90%
SpO ₂ média	97%
SpO ₂ máxima	100%
Tempo com SpO ₂ < 90%	0,0 min (0%)
Número de dessaturações ¹	29
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	3,6 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	2,9 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	24,5 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	36,0 min
Tempo com ronco total	0,0 min (0%)
Tempo com ronco baixo	0,0 min (0%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	45 bpm
Média	57 bpm
Máxima	101 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	0
Tempo total em FA	-
Episódio de menor duração	-
Episódio de maior duração	-
Duração média dos episódios	-
Risco de FA	Baixo

Sono estimado

Tempo total de sono	471,0 min
Tempo para dormir	3,5 min
Tempo acordado pós-sono	16,5 min
Eficiência do sono	95%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia Multimodal

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Daniel Francisco Da Silva	Nascimento	08/07/1979 (46 anos)	Sexo	Masculino
Início	25/04/2026 - 23:19:17	Tempo total	08:14:10 (494,2 min)		

Polissonogramas

